



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PANDUAN MANAJER PELAYANAN PASIEN

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 319.35/I-PND/IGD/IV/2025

Tentang
Panduan Manajer Pelayanan Pasien

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Manajer Pelayanan Pasien dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada. Panduan Manajer Pelayanan Pasien ini yang dipergunakan pada tahun 2025 meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab Manajer Pelayanan Pasien di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Manajer Pelayanan Pasien ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur mazidah

TIM PENYUSUN
PANDUAN MANAJER PELAYANAN PASIEN

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR	v
PERATURAN DIREKTUR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud, Tujuan, Dan Fungsi	4
BAB II DEFINISI	5
BAB III RUANG LINGKUP	5
3.1 Ruang Lingkup Panduan Manajer Pelayanan Pasien	7
BAB IV TATA LAKSANA	7
4.1 Tata Laksana MPP	8
4.2 Diagram Koordinasi – Integrasi – Kontinuitas Pelayanan	8
4.3 Peran MPP	9
4.4 Pelaksanaan Asuhan Pasien Terintegrasi	9
4.5 Hasil Yang Diharapkan	9
4.6 Tangung Jawab	10
4.7 Rekam Medis MPP	11
BAB V KUALIFIKASI MANAJER PELAYANAN PASIEN	11
5.1 Kualifikasi	11
5.2 Pelatihan Tambahan	12
BAB VI DOKUMENTASI	12

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 319.35/I-PND/IGD/IV/2025

TENTANG

PANDUAN MANAJER PELAYANAN PASIEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Prima Husada, untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam hal manajer pelayanan pasien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Manajer Pelayanan Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2022: tentang Rekam Medis
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAHUSADA MALANG TENTANG PANDUAN MANAJER PELAYANAN PASIEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Panduan manajer pelayanan digunakan sebagai acuan dalam organisasi dan manajemen di Rumah Sakit Prima Husada.

BAB II

TUGAS MANAJER PELAYANMAN

Pasal 2

- (1) MPP ditunjuk dengan uraian tugas antara lain dalam konteks menjaga kesinambungan dan koordinasi pelayanan bagi individu pasien melalui komunikasi dan kerjasama dengan PPA dan pimpinan unit
- (2) Pelaksanakan proses kesinambungan pelayanan serta koordinasi pelayanan di rumah sakit dilakukan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) dibantu oleh manajer pelayanan pasien (MPP)/*Case Manager*.

Pasal 3

- (1) Pasien diskriming untuk kebutuhan pelayanan manajemen pelayanan pasien
- (2) Pasien yang mendapat pelayanan MPP, pencatatannya dilakukan dalam Form MPP selalu diperbaharui untuk menjamin komunikasi dengan PPA

Pasal 4

- (1) Kesinambungan dan koordinasi proses pelayanan didukung dengan menggunakan perangkat pendukung, seperti rencana asuhan PPA, catatan MPP, panduan, atau perangkat lainnya
- (2) Kesinambungan dan koordinasi dapat dibuktikan di semua tingkat/fase asuhan pasien

Pasal 5

Pemulangan pasien yang rencana pemulangannya kompleks (*discharge planning*) dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.

Pasal 6

Aktivitas manajer pelayanan pasien (MPP) dicatat dalam rekam medis

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panduan Manajer Pelayanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 sampai pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.



Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 04 April 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 319.35/I-PND/IGD/IV/2025
TENTANG
PANDUAN MANAJER PELAYANAN PASIEN

PANDUAN MANAJER PELAYANAN PASIEN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perjalanan pasien di rumah sakit mulai dari admisi, keluar pulang, atau pindah melibatkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA), unit kerja, dan manajer pelayanan pasien (MPP). Selama dalam berbagai tahap pelayanan, kebutuhan pasien dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di rumah sakit dan kalau perlu sumber daya dari luar. Kesenambungan pelayanan berjalan baik jika semua pemberi pelayanan mempunyai informasi yang dibutuhkan tentang kondisi kesehatan pasien terkini dan sebelumnya agar dapat dibuat keputusan yang tepat.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan dengan pola pelayanan berfokus pada pasien (PCC). Pola ini dipayungi oleh konsep WHO: *Conceptual framework integrated people-centered health services*. (WHO global strategy on integrated people-centered health services 2016-2026, July 2015).

Pelayanan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap profesional pemberi asuhan (PPA) adalah sama pentingnya atau sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ketinggian pelayanan yang berbeda maka peranan manajer pelayanan pasien (MPP) penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai terhadap profesional pemberi asuhan (PPA).

Selama dirawat inap di rumah sakit, pasien mungkin dipindah dari satu pelayanan atau dari satu unit rawat inap ke berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain. Jika profesional pemberi asuhan (PPA) berubah akibat perpindahan ini maka informasi penting terkait asuhan harus mengikuti pasien. Pemberian obat dan tindakan lain dapat berlangsung tanpa halangan dan kondisi pasien dapat dimonitor. Untuk memastikan setiap tim asuhan menerima informasi yang diperlukan maka rekam medis pasien ikut pindah atau ringkasan informasi yang ada di rekam medis disertakan waktu pasien pindah dan menyerahkan kepada tim asuhan yang menerima pasien. Ringkasan memuat sebab pasien masuk dirawat, temuan penting, diagnosis, prosedur atau tindakan, obat yang diberikan, dan keadaan pasien waktu pindah.

Bila pasien dalam pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) maka kesinambungan proses tersebut di atas dipantau, diikuti, dan transfernya disupervisi oleh manajer pelayanan pasien (MPP).

Memulangkan pasien ke rumah atau keluarga, didasarkan atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhannya untuk memperoleh kesinambungan asuhan. Dapat juga pasien dirujuk atau dikirim ke praktisi kesehatan di luar rumah sakit. Dokter

penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bertanggung jawab atas asuhan pasien menentukan kesiapan pasien keluar rumah sakit berdasar atas kebijakan, kriteria, dan indikasi rujukan yang ditetapkan rumah sakit. Kebutuhan kesinambungan asuhan berarti rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik, atau bahkan kebutuhan upaya preventif di rumah yang dikoordinasikan oleh keluarga pasien. Diperlukan proses yang terorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa kesinambungan asuhan dikelola oleh praktisi kesehatan atau oleh sebuah organisasi di luar rumah sakit. Pasien yang memerlukan perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) maka rumah sakit mulai merencanakan hal tersebut sedini-dininya yang sebaiknya untuk menjaga kesinambungan asuhan dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait/relevan serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Keluarga dilibatkan dalam proses ini sesuai dengan kebutuhan.

Dibutuhkan perencanaan untuk mengatur tindak lanjut pemulangan pasien ke praktisi kesehatan atau organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan kesinambungan asuhan pasien. Rumah sakit yang berada di komunitas tempat praktisi kesehatan juga berada di dalamnya membuat kerja sama formal dan informal. Jika pasien berasal dari komunitas/daerah lain maka rumah sakit akan merujuk pasien ke praktisi kesehatan yang berasal dari komunitas tempat pasien tinggal.

Mungkin juga, pasien membutuhkan pelayanan dukungan dan pelayanan kesehatan pada waktu pasien keluar dari rumah sakit (*discharge*). Misalnya, pasien mungkin membutuhkan bantuan sosial, nutrisi, keuangan, psikologi, atau bantuan lain pada waktu pasien keluar rumah sakit. Proses perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP) memuat bentuk bantuan pelayanan yang dibutuhkan dan ketersediaan bantuan yang dimaksud.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

1. Maksud

Maksud disusunnya Panduan Manajer Pelayanan Pasien adalah untuk digunakan sebagai panduan atau acuan bagi para Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dalam memberikan pelayanan pada pasien

2. Tujuan MPP

Tujuan MPP adalah untuk melibatkan pasien dalam asuhan yang dialaminya. Bilamana pasien merasa menjadi bagian dalam keputusan pengobatan dan rencana asuhan, maka mereka akan memperoleh manfaat. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarganya. Bila keluarga yang mempunyai relasi erat, suatu kemitraan dengan rumah sakit yang melayani orang yang mereka kasihi, mereka akan kurang merasa khawatir tentang logistik dan akan lebih banyak fokus terhadap kesehatan pasien.

3. Fungsi MPP

a. Asesmen utilitas.

Mampu mengakses semua informasi dan data untuk mengevaluasi manfaat/utilisasi, untuk kebutuhan manajemen pelayanan pasien. (Semua informasi dan data akurat, lengkap yang mudah diakses tentang kebutuhan klinis, finansial, serta sosial pasien)

b. Perencanaan.

Dengan asesmen yang lengkap, disusun perencanaan untuk pelaksanaan manajemen pelayanan pasien. Perencanaan tsb mencerminkan kelayakan/kepatutan dan efektivitas-biaya dari pengobatan medis dan klinis serta kebutuhan pasien untuk mengambil keputusan.

c. Fasilitasi.

Tugas ini mencakup interaksi antara MPP dan para anggota tim pemberi pelayanan kesehatan, perwakilan pembayar, serta pasien/keluarga yang mencari/menginginkan pembebasan dari hambatan namun dapat mempengaruhi kinerja/hasil, serta menjaga kontinuitas pelayanan.

d. Advokasi.

Mewakili kepentingan pasien adalah inti dari peran MPP. Tetapi peran ini juga menjangkau pemangku kepentingan lain. MPP diharapkan melakukan advokasi untuk opsi pengobatan yang dapat diterima setelah berkonsultasi dengan DPJP, termasuk rencana pemulangan yang aman. Advokasi perlu mempertimbangkan sistem nilai pasien, kemampuan finansial termasuk atas jaminan pembiayaan, pilihan, serta kebutuhan pelayanan kesehatannya

BAB II

DEFINISI

1. Manajer Pelayanan Pasien – MPP (*Case Manager*) adalah professional di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien
2. Manajemen Pelayanan Pasien:
 - a. Suatu proses kolaboratif mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil (outcome) yang bermutu dengan biaya-efektif. (Sumber: CSMA – Case Management Society of America, 2010)
 - b. Suatu model klinis untuk manajemen strategik mutu dan biaya pelayanan, dibuat untuk memfasilitasi hasil pasien yang diharapkan dalam lama perawatan yang layak /patut dan dengan manajemen sumber daya yang sesuai. (Cesta, 2009)
3. Asesmen utilitas : kegiatan mengevaluasi utilisasi / pemanfaatan sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

3.1. Ruang lingkup Panduan Manajer Pelayanan Pasien meliputi:

a. Pelayanan Fokus Pada Pasien (*Patient Centered Care*).

Manajemen pelayanan pasien bersumber dari konsep pelayanan fokus pada pasien (PFP).

Pelayanan berfokus pada pasien (PCC) diterapkan dalam bentuk asuhan pasien terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap PPA sama pentingnya/sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda, di sini peran MPP penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai dengan PPA.

Inti konsep PFP terdiri dari 4 elemen:

1. Martabat dan Respek
 - a. Pemberi pelayanan kesehatan mendengarkan, menghormati dan menghargai pandangan dan pilihan pasien serta keluarga.
 - b. Pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, latar belakang kultural pasien dan keluarga dimasukkan dalam perencanaan pelayanan dan pemberian pelayanan kesehatan
2. Berbagi informasi
 - a. Pemberi pelayanan kesehatan mengkomunikasikan dan berbagi informasi secara lengkap dengan pasien dan keluarga
 - b. Pasien dan keluarga menerima informasi tepat waktu, lengkap, dan akurat
3. Partisipasi
 - a. Pasien dan keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi dalam asuhan dan pengambilan keputusan serta pilihan mereka
4. Kolaborasi / kerjasama.
 - a. Pasien dan keluarga adalah mitra pemberi pelayanan kesehatan. Pemberi pelayanan kesehatan bekerjasama dengan pasien dan keluarga dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan program.

b. Hubungan Profesional

Para MPP harus mempunyai hubungan kerja profesional dengan para dokter dan staf klinis. Mereka juga harus terbiasa dengan pelayanan penagihan (*billing*), pelayanan bantuan finansial, bantuan/dukungan dari komunitas serta pelayanan kerohanian.

c. Hubungan Dengan Pasien

Penting bagi para MPP untuk memiliki relasi dengan pasien dan keluarga. MPP perlu memelihara rasa saling percaya yang menunjukkan kepada pasien bahwa mereka terlibat untuk manfaat dan kepentingan pasien. Untuk itu MPP perlu memperhatikan secara aktif kebutuhan dan keinginan pasien.

d. Kelompok Pasien

MPP sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada pasien-pasien dalam kelompok: anak-anak, usia lanjut, dan yang dengan penyakit kronis.

Dalam pelaksanaan manajemen pelayanan pasien, MPP dapat menangani 25 – 50 pasien, tergantung kondisi kerumitan, sistem pelayanan klinis, budaya kerja rumah sakit.

BAB IV

TATA LAKSANA

4.1. Tata Laksana MPP

1. Penetapan dan Pengangkatan MPP oleh Direktur
2. Melakukan skrining pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien, berdasarkan pasien yang meliputi:
 - a. Risiko tinggi
 - b. Biaya tinggi
 - c. Potensi komplain tinggi
 - d. Kasus dengan penyakit kronis
 - e. Kasus kompleks / rumit
 - f. Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks
3. Setelah pasien ditentukan sebagai klien MPP, maka dilakukan asesmen utilitas dengan mengumpulkan berbagai informasi klinis, psiko-sosial, sosio- ekonomis, maupun sistem pembayaran yang dimiliki pasien
4. Menyusun rencana manajemen pelayanan pasien tersebut, berkolaborasi dengan DPJP serta para anggota tim klinis lainnya, yang mencerminkan kelayakan / kepatutan dan efektivitas-biaya dari pengobatan medis dan klinis serta kebutuhan pasien untuk mengambil keputusan
5. Melakukan fasilitasi yang mencakup interaksi antara MPP dan DPJP serta para anggota tim klinis lainnya, berbagai unit pelayanan, pelayanan administrasi, perwakilan pembayar. Fasilitasi untuk koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara pasien dan pemangku kepentingan, serta menjaga kontinuitas pelayanan.
6. Memfasilitasi untuk kemungkinan pembebasan dari hambatan yang tidak mempengaruhi kinerja/hasil
7. Memfasilitasi dan memberikan advokasi agar pasien memperoleh pelayanan yang optimal sesuai dengan sistem pembiayaan dan kemampuan finansial
8. Ada bukti dokumentasi kegiatan MPP, a.l. termasuk dalam rekam medis seperti pencatatan dalam formulir edukasi-informasi.

4.2. Diagram Koordinasi – Integrasi – Kontinuitas Pelayanan



4.3. Peran MPP

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) bukan merupakan profesional pemberi asuhan (PPA aktif dan dalam menjalankan manajemen pelayanan pasien mempunyai peran minimal adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien;
- b. mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;
- c. mengoptimalkan proses reimbursemen; dan dengan fungsi sebagai berikut:
- d. asesmen untuk manajemen pelayanan pasien;
- e. perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;
- f. komunikasi dan koordinasi;
- g. edukasi dan advokasi;
- h. kendali mutu dan biaya pelayanan pasien.

Pasien, keluarga, dan mereka yang memutuskan menerima cukup penjelasan untuk berpartisipasi dalam keputusan asuhan pasien dan memberikan persetujuan yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan pasien maka penjelasan tersebut diberikan secara terintegrasi oleh para profesional pemberi asuhan (PPA) terkait dibantu oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Informasi itu memuat:

- b. risiko dari rencana tindakan operasi;
- b. manfaat dari rencana tindakan operasi;
- c. kemungkinan komplikasi dan dampak;
- d. pilihan operasi atau nonoperasi (alternatif) yang tersedia untuk menangani pasien;
- e. sebagai tambahan jika dibutuhkan darah atau produk darah, sedangkan risiko dan alternatifnya didiskusikan.

Dokter bedah yang kompeten dan berwenang serta PPA yang terkait memberikan informasi ini.

4.4. Pelaksanaan Asuhan Pasien Terintegrasi

Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berpusat pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.
- b. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai Ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (*Clinical Leader*).
- c. Profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya, Alur Klinis/ *Clinical Pathway* terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, *Standing Order* dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi);
- d. Perencanaan pemulangan pasien (P3)/ *Discharge Planning* terintegrasi;
- e. Asuhan gizi terintegrasi
- f. Manajer pelayanan pasien/*case manager*.

4.5. Hasil Yang diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen pelayanan pasien antara lain adalah:

- a. Pasien mendapat asuhan sesuai dengan kebutuhannya;
- b. Terpelihara kesinambungan pelayanan;
- c. Pasien memahami/mematuhi asuhan dan peningkatan kemandirian pasien;
- d. Kemampuan pasien mengambil keputusan;
- e. Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga;
- f. Optimalisasi sistem pendukung pasien;
- g. Pemulangan yang aman;
- h. Kualitas hidup dan kepuasan pasien.

4.6. Tanggung Jawab

MPP bertanggung-jawab ke Manajer Pelayanan Medis

4.7. Rekam Medis MPP

Rekam medis pasien merupakan sumber informasi utama tentang proses pelayanan dan kemajuannya sehingga merupakan alat komunikasi penting. Rekam medis selama rawat inap dan rawat jalan dengan catatan terkini tersedia agar dapat mendukung serta bermanfaat untuk kesinambungan pelayanan pasien. Profesional pemberi asuhan (PPA) melakukan asesmen pasien berbasis informasi, analisis dan (IAR) sehingga informasi manajer pelayanan pasien (MPP) juga dibutuhkan.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan manajemen pelayanan pasien, manajer pelayanan pasien (MPP) mencatat pada lembar form A yang merupakan evaluasi awal manajemen pelayanan pasien dan form B yang merupakan catatan implementasi manajemen pelayanan pasien. Kedua form tersebut merupakan bagian rekam medis.

Pada form A dicatat antara lain identifikasi/skrining pasien untuk kebutuhan pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) dan asesmen untuk manajemen pelayanan pasien termasuk rencana, identifikasi masalah–risiko – kesempatan, serta perencanaan manajemen pelayanan pasien, termasuk memfasilitasi proses perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*).

Pada form B dicatat antara lain pelaksanaan rencana manajemen pelayanan pasien, monitoring, fasilitasi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi, advokasi, hasil pelayanan, serta terminasi manajemen pelayanan pasien.

Agar kesinambungan asuhan pasien tidak terputus, rumah sakit harus menciptakan proses untuk melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan di antara profesional pemberi asuhan (PPA), manajer pelayanan pasien (MPP), pimpinan unit, dan staf lain sesuai dengan regulasi rumah sakit di beberapa tempat:

- a. Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap;
- b. Pelayanan diagnostik dan tindakan;
- c. Pelayanan bedah dan nonbedah;
- d. Pelayanan rawat jalan;
- e. Organisasi lain atau bentuk pelayanan lainnya.

Proses koordinasi dan kesinambungan pelayanan dibantu oleh penunjang lain seperti panduan praktik klinis, alur klinis/*clinical pathways*, rencana asuhan, format rujukan, daftar tilik/check list lain, dan sebagainya.

BAB V

KUALIFIKASI MANAJER PELAYANAN PASIEN

5.1. KUALIFIKASI

1. Dokter Umum atau Perawat dengan pendidikan S 1
2. Pengalaman minimal 3 – 5 tahun dalam pelayanan klinis
 - a. Dokter: sebagai dokter ruangan
 - b. Perawat: sebagai kepala ruangan

5.2. PELATIHAN TAMBAHAN

1. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan klinis terkait dengan penyusunan dan penerapan SPO Pelayanan Kedokteran yang terdiri dari Panduan Praktik Klinis, Alur Klinis (Clinical Pathway), Algoritme, Protokol, Standing order.
2. Pelatihan Pelayanan Fokus pada Pasien (PFP) / Patient Centered Care (PCC).
3. Pelatihan tentang perasuransian, jaminan kesehatan nasional, INA-CBG's
4. Pelatihan tentang Perencanaan pulang (Discharge planning) untuk kontinuitas pelayanan
5. Pelatihan Manajemen Risiko
6. Pelatihan untuk meningkatkan *soft skill* (pengetahuan aspek psiko-sosial, hubungan interpersonal, komunikasi, dsb)

BAB VI

DOKUMENTASI

Form A – Evaluasi Awal MPP

FORM MPP (FORM A dan FORM B)

RM 13.19



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

(Etiket Pasien)

Form A – Evaluasi awal MPP (Case Manager)

Ruangan :

Tgl, Jam	Catatan
	- Identifikasi / Skrining pasien ☐ Usia lanjut ☐ Kasus penyakit kronis/ terminal katastropik ☐ Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll) ☐ Perkiraan biaya tinggi ☐ Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi) ☐ Pasien dengan fungsi kognitif rendah ☐ Potensial complain tinggi ☐ Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat ☐ Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya ☐ Beresiko membutuhkan kontinuitas pelayanan ☐ Berpotensi masalah hukum ☐ Naik kelas pelayanan ☐ Lain-lain:.....
	- Asesmen untuk manajemen pelayanan pasien - Fisik fungsional : partial/total care - Koqnitif : kooperatif/ tidak kooperatif - Pemahaman tentang Kesehatan : kurang/ cukup/ tidak mampu - Dukungan keluarga : ada/ tidak ada - Perencanaan lanjutan : dirujuk ke komunitas..... - Lain-lain:..... Kepatuhan pasien : ya / tidak
	- Identifikasi masalah – risiko – kesempatan - -
	- Perencanaan manajemen pelayanan pasien - Pendekatan kepada pasien - Jelaskan kepada pasien tentang kondisi dan kemungkinan rencana pelayanan yang akan dilakukan - Lakukan koordinasi dengan PPA untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit dan segala permasalahannya termasuk rencana pemulangan pasien - Edukasi terhadap keluarga terkait permasalahan pasien - Lain-lain:.....

	● Perencanaan manajemen pelayanan pasien - Pendekatan kepada pasien - Jelaskan kepada pasien tentang kondisi dan kemungkinan rencana pelayanan yang akan dilakukan - Lakukan koordinasi dengan PPA untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit dan segala permasalahannya termasuk rencana pemulangan pasien - Edukasi terhadap keluarga terkait permasalahan pasien - Lain-lain:.....
--	--

Form B – Catatan Implementasi MPP

Etiket
pasien

TANGGAL JAM	CATATAN	PARAF NAMA MPP

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah